

INFILTRACIÓN EN HOMBRO

Patricia Méndez Da Cuña, Vanesa Amores Sierra, Jacinto Rodríguez Albo, Juan José González Fernández.

INDICACIONES

La infiltración de hombro es una técnica que consiste en la aplicación directa de principios activos en el hombro patológico.

Los objetivos de la infiltración de hombro son:

- Aliviar o suprimir localmente la inflamación y con ello el dolor.
- Recuperar la funcionalidad y movilidad del hombro suprimiendo el dolor.
- Acelerar la recuperación funcional en caso de lesiones agudas (esguinces, tendinitis, etc).
- Disminuir, sustituir o eliminar la necesidad de tratamientos más agresivos con importantes efectos secundarios o contraindicados.

Las indicaciones de esta técnica son:

- Artritis agudas y/o crónicas inflamatorias (no infecciosas) que no responden a tratamiento sistémico.
- Tendinitis manguito rotador.
- Tendinitis tendón porción larga del bíceps.
- Tenosinovitis.
- Bursitis.

Lo que no se debe olvidar en urgencias:

- No infiltrar más de 3 o 4 veces la misma articulación en 1 año.
- Espaciar 3-4 semanas las infiltraciones para valorar el resultado
- No infiltrar en cada sesión más de 2 articulaciones por la posibilidad de mayor absorción sistémica.

Las contraindicaciones de la infiltración del hombro son las siguientes:

Contraindicaciones absolutas	Contraindicaciones relativas
• Sospecha de artritis séptica	• Trastorno de la coagulación o tratamiento anticoagulante
• Infección sistémica o infección cutánea en el lugar de la infiltración	• Diabetes mellitus mal controlada
• Inestabilidad articular	• Hemartrosis
• Fractura intraarticular	• Prótesis u osteosíntesis
• Placa de psoriasis en el punto de infiltración	• Embarazo
• Alergia o hipersensibilidad de los fármacos utilizados	• Haber realizados infiltraciones previas sin efectos beneficiosos

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

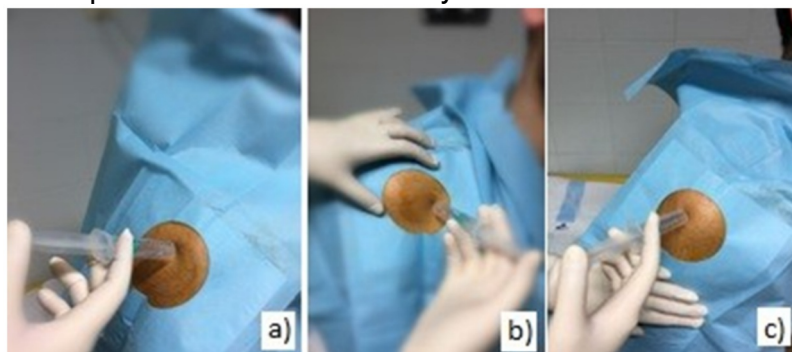
Explicar al paciente la técnica, los beneficios y las posibles complicaciones.

Pasos a seguir:

- Colocar al paciente en una posición cómoda (mejor sentado con brazo relajado).
- Explorar y marcar el punto de entrada de la aguja.
- Asepsia de la zona con povidona yodada o alcohol 70%.
- Lavado de manos y colocación de campo con guantes estériles.
- Cargar con aguja estéril la jeringuilla también estéril con el medicamento: primero corticoide y luego el anestésico local.
- Cambiar la aguja por otra estéril para la infiltración.
- Realizar la infiltración.
- Compresión de la zona para evitar sangrados.

Las diferentes vías de infiltración del hombro son:

- **Posterior:** el médico se sitúa detrás del paciente. Se palpa el borde posterior del acromion con el pulgar y la apófisis coracoides con el índice. La infiltración se realiza 1-2 cm por debajo del borde posterior del acromion. La aguja se dirige de forma perpendicular al plano cutáneo, en sentido anterior hacia la apófisis coracoides.
- **Anterior:** el médico se sitúa delante del paciente. El punto de entrada se localiza 1 cm. por debajo y 1 cm. externo a la apófisis coracoides. La dirección de la aguja es perpendicular al plano cutáneo, entre la cabeza humeral y la glena, levemente inclinada hacia arriba.
- **Lateral o externa:** 1cm por debajo del extremo lateral del acromion, en el surco acromiohumeral, en sentido ligeramente ascendente. Si se introduce la aguja hasta la mitad podemos llegar a la bolsa subacromial y si se introduce entera, infiltraremos el supraespinoso.
- **Articulación acromioclavicular:** con el brazo en posición neutra, se localiza la línea articular en la parte superior del hombro y se introduce la aguja.
- **Corredera bicipital:** en el caso de tendinitis del tendón de la porción larga del bíceps. Se palpa la corredera bicipital y se infiltra el tendón con el brazo en abducción y ligera rotación externa. El líquido ha de penetrar entre el tendón y la vaina sinovial.



Vías de infiltración del hombro: a) posterior; b) anterior; c) lateral.

MATERIALES

Material para realizar una infiltración. Fig.2.

- Jeringas 5cc y 2 agujas intramusculares (verdes) o espinales (18-22), una para cargar la medicación y otra para infiltración.
- Guantes, gasas y paños estériles.

- **Antisépticos:** povidona yodada, alcohol 70º
- **Fármacos:**
 - **Corticoides:**
 - Triancinolona Acetónido (Trigon depot®): 40mg
 - Betametasona Acetato (Celestone cronodose®): 6mg
 - **Anestésicos locales:**

Nombre	%	Comienzo	Duración
Lidocaína	1-2	1-2 min	1 h
Mepivacaína	1	2-5 min	1-2 h
Bupivacaína	0.25-0.50-0.75	5 min	3-5 h
Ropivacaína	0.2	5 min	3-5 h

- **Dosis:** normalmente se utiliza 1 ampolla de corticoide y 1 ampolla de 2ml de anestésico local.



Figura 2. Material empleado para desarrollar la técnica.

BIBLIOGRAFÍA

- Rivero Franco I, Navarro Massip L. Infiltraciones (I). Infiltración del hombro doloroso. AMF 2010;6(2):83-87.
- Rodríguez Alonso JJ, Fahandez-Saddi H, Flórez García M, Gracia Santos J, Gómez Gómez B, Holgado Catalán S et al. Traumatología de partes blandas. AMF 2008;4(5):244-52.
- Lizan Tudela L, Balanzá Garzón A. Guía de actuación en atención primaria. Barcelona: Semfyc; 2006. p. 1746-52.